

QCM 4

www.ispits.net

1- : Les CNS ont pour objectif de

- A- Déterminer toutes les dépenses de sante dans le pays
- B- Dresser un tableau exhaustif des moyens mis en œuvre par chaque intervenant dans le domaine de la sante
- C- Traduire à un instant donné la répartition du poids supporté par chaque intervenant dans le domaine de la sante
- D- Fournir aux décideurs un éventail de données

- Rep:

2- Pour comparer deux (ou plusieurs) procédures en évaluant leurs couts en DH et leurs résultats en unités telles que le nombre d'années de vie gagnées ou de malades sauvés, on procède à :

- A- Une analyse cout-utilité
- B- Une analyse cout-opportunité
- C- Une analyse cout-bénéfice
- D- une analyse cout-efficacité
- E- Une minimisation du cout

Rep:

3- Quelque soit l'organisme gestionnaire, le régime d'assurance maladie obligatoire de base couvre

A- Le (les) conjoint (s) de l'assuré

B- Leurs enfants à charge âgés de 19 ans au plus

C- Leurs enfants à charge non mariés âgés de 21 ans au plus et poursuivant des études supérieures

D- Leurs enfants handicapés à charge, sans limite d'âge

E- Les parents de l'assuré

Rep:

4- Dans son article 73, la loi 65-00 a confiée la gestion de l'AMO pour les fonctionnaires des CL à :

A- CNSS

B- INAYA

C- CNOPS

D- CMIM

E- CMR

Rep:

C

5- Dans le cadre de l'AMO et en cas de maladie grave ou invalidante nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux, la part restant à la charge de l'assuré ne peut être supérieure à :

A- 2,5% de la tarification nationale de référence
TNR

B- 5% de la TNR

C- 10% de la TNR

D- 15% de la TNR

E- Exonération totale

Rep:

C

6- Parmi les propositions suivantes ayant trait aux mesures d'accompagnement de l'optimisation, la régulation et la maîtrise des dépenses de santé pour assurer la pérennité et la viabilité financière de l'AMO, une est fausse, laquelle :

- A- L'adoption d'une liste des médicaments admis au remboursement
- B- L'adoption d'une liste des ALD fixée par arrêté du MS
- C- l'organisation par les organismes gestionnaires de l'AMO de services chargés du contrôle médical
- D- La conclusion de conventions de tarification avec les prestataires de soins publics et privés
- E- La généralisation de la couverture médicale à toutes les catégories socioprofessionnelles

Rep:

E

7- Le panier de soins couvert par l'AMO est fixé par l'article 7 de la loi 65-00 portant code de la couverture médicale de base. Les quels sont PEC par la CNOPS:

- A- Les interventions de chirurgie esthétique, les cures thermales, l'acupuncture, la mésothérapie, l'homéopathie et les prestations dispensées dans le cadre de la médecine douce
- B- Les soins préventifs et curatifs, liés aux programmes prioritaires entrant dans le cadre de la politique sanitaire de l'Etat
- C- Les actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales
- D- Les poches de sang humains et dérivés sanguins
- E- Les soins reliés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles

Rep:

B-C-D

8- Le financement du RAMED est assuré par:

- A- Budget du MS
- B- Agence Nationale d'assurance maladie (ANAM)
- C- Participation forfaitaire des économiquement faibles relatifs
- D- Participation forfaitaire des économiquement faibles absolus
- E- Les collectivités locales

Rep:

C-E

8- Le prix des médicaments génériques sont, en règle générale, inférieures à ceux des spécialités et ceci pour les raisons suivantes :

- A- Parce qu'ils ont un prix de recherche à amortir
- B- Parce un prix supérieur constitue souvent un atout non négligeable face à une concurrence bien installée
- C- Parce que les spécialités génériques ont des marges plus importantes que celles des spécialités princeps
- D- Parce qu'ils doivent justifier d'un avantage économique par rapport à leur spécialités princeps
- E- Parce qu'ils supportent des couts de promotion importants

Rep:

9- Son internalisation permettra aux ordonnateurs d'assumer des responsabilités supplémentaires dans l'engagement de la dépense publique, s'agit-il de:

A- La lettre de cadrage

B- Le cadre des dépenses à moyen terme (CDMT)

C- La gestion intégrée des dépenses (GID)

D- Le budget programme

E- Le contrôle modulé des dépenses

Rep:

10- Lequel parmi ces indices de mesure de la gouvernance des systèmes de n'est pas retenu par l'OMS :

A- La mesure de la réactivité du système de santé

B- La consommation médicale

C- La mesure de la performance en matière du niveau de santé

D- L'équité de la contribution au système de santé

E- Les dépenses de santé/PIB

Rep:

11- Quels sont les bénéficiaires du RAMED:

www.ispits.net

- A- Les bénéficiaires par éligibilité (pauvres et vulnérables)
- B- Les bénéficiaires de droit (les pensionnaires des établissements de bienfaisance, des établissements pénitentiaires, les SDF,...)
- C- Les bénéficiaires de droit et leur ayant droit
- D- Les bénéficiaires de droit et par éligibilité

Rep:

12- L'estimation des besoins en médicaments par la méthode fondée sur la morbidité pour un service X nécessite:

- A- De connaître la consommation mensuelle moyenne
- B- Les schémas types de traitement pour chaque pathologie
- C- Le cout global par pathologie traité au service
- D- Le nombre de cas par pathologie traité au service pour une période donnée

Rep:

13- Les critères d'allocation des ressources budgétaires aux différentes régions font intervenir:

A- La production de services (activité sanitaire),

B- La répartition des infrastructures

C- La performance des structures sanitaires

D- La population résidente de chaque région, pondérée par des indicateurs de besoin

Rep:

A-B-C-D

14- La réglementation rendant obligatoire la déclaration des maladies infectieuses au Maroc a été publiée en :

A- 1995

B- 1983

C- 1975

D- 1967

Rep:

Déclaration Obligatoire des Maladies - Bases Juridiques - (1)

1. Décret Royal

- N° 554-65 du 26/06/1967 portant loi rendant la déclaration de certaines maladies obligatoire et prescrivant les mesures prophylactiques propres à enrayer ces maladies
- Publications : B.O. du 5 Juillet 67 p. 737

15- La liste des maladies à déclaration obligatoire est composée d'un nombre compris entre :

A- 10 et 15

B- 20 et 25

C- 30 et 35

D- 35 et 40

Rep:

Liste des maladies à déclaration obligatoire

- Maladies soumises au règlement sanitaire international
- Maladies pouvant donner lieu à des poussées épidémiques
- Autres maladies à déclaration obligatoire

Liste des maladies à déclaration obligatoire

1. Maladies soumises au règlement sanitaire international

- La peste,
- La fièvre jaune,
- Le choléra

Liste des maladies à déclaration obligatoire

2. Maladies pouvant donner lieu à des poussées épidémiques:

- La diphtérie, Le tétanos, La poliomyélite et les PFA
- La rougeole, La coqueluche et La tuberculose,
- Le paludisme, La bilharziose et La lèpre,
- Le SIDA et Les MST,
- La syphilis primo-secondaire,
- Les infections méningococciques
- Les fièvres typhoïde et paratyphoïdes,
- Les TIAC,
- La rage humaine,
- Le trachome.

Liste des maladies à déclaration obligatoire

3. Autres maladies à déclaration obligatoire :

- Le rhumatisme articulaire aigu,
- Les leishmanioses, Le charbon humain et La brucellose,
- Les hépatites virales,
- La leptospirose,
- Le typhus exanthématique et La fièvre récurrente,
- La conjonctivite gonococcique du nouveau-né.

Liste des maladies à déclaration obligatoire

3. Nouvelles maladies rendues à déclaration obligatoire :

- Maladie de Creutzfeldt-Jakob et les maladies apparentées,
- Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS),
- La fièvre hémorragique de Crimée-Congo,
- La fièvre de la Vallée du Rift,
- La fièvre du Nil Occidental,
- L'hydatidose.

Contexte international

www.ispits.net

Engagement du Maroc dans des projets où la surveillance est primordiale :

Eradication : poliomyélite

Elimination : TNN, rougeole, bilharziose, lèpre, cécité par trachome ...

Contrôle : IST, diabète, RAA ...

Surveillance des maladies émergentes et réémergentes

Environnement et santé

Surveillance euro-méditerranéenne

16- Quels sont les programmes définis dans la stratégie nationale en santé mentale :

- A- Le programme de lutte contre l'usage d'alcool
- B- Le programme de santé mentale de l'enfant et de l'adolescent
- C- Le programme de lutte contre les toxicomanies
- D- Le programme de lutte contre les psychoses

Rep:

17- Le ratio médecin/infirmier préconisé par l'OMS
est de :

A- Un médecin pour deux infirmiers

B- Un médecin pour 3 infirmiers

C- Un médecin pour quatre infirmiers

D- Un médecin pour cinq infirmiers

Rep:

18- L'hôpital local public comprend
obligatoirement la/les discipline(s) suivante(s) :

A- La chirurgie

B- L'obstétrique

C- L'ophtalmologie

D- La pédiatrie

Rep:

19- Laquelle ou lesquelles des maladies suivantes font l'objet de programmes ou de stratégies sanitaires au niveau national au Maroc :

A- Paludisme

B- Dengue

C- VIH/SIDA

D- Le cancer du foie

E- Diabète

Rep:

20- Le paquet minimum d'action des ESSB au Maroc comprend les activités suivantes :

A- Le dépistage et PEC de la malnutrition infantile

B- La vaccination

C- La planification familiale

D- Le suivi de la grossesse

E- La PEC des cancers du sein et du col utérin

Rep:

21- Le processus de contrôle de gestion des prestations de soins comprend :

A- Le choix et le déclenchement d'actions correctives

B- La définition des objectifs

C- La réunion de l'équipe de soins

D- L'établissement d'une référence

Rep:

22- Quels sont les scénarios possibles dans le rapport cout-qualité :

A- Améliorer la qualité par l'augmentation des couts

B- Améliorer la qualité à cout constant

C- Diminuer les couts et augmenter la qualité

D- Réduire les cout à qualité constante

Rep:

23- L'évaluation des prestations de soins est basée sur des normes et des critères. Parmi les normes citées ci-dessous, quelle(s) est/sont celle(s) en rapport avec la PEC du patient :

- A- La répartition quotidienne du personnel est équitable selon la charge de travail
- B- La programmation des soins est révisée régulièrement selon la prescription médicale
- C- Une secrétaire hospitalière (médicale) est présente parmi le staff du personnel soignant
- D- L'approvisionnement en médicaments urgents est assuré en dehors des heures ouvrables de la pharmacie

Rep:

24- Parmi les significations ci-après quelle(s) est/sont celle(s) qui se rapproche(ent) à l'indicateur :

- A- Un indicateur apporte une visibilité sur des éléments organisationnels du service
- B- Un indicateur est un résultat de soins observés
- C- C'est un indice facilitant la récolte continue des données
- D- Un indicateur est une information ayant un sens pour son utilisateur

Rep:

25- Les indicateurs des résultats immédiats portent sur :

A- La notion d'équité

B- La notion de couts visibles et cachés

C- La notion d'efficacité

D- La notion de productivité

Rep:

26- Parmi les propositions suivantes quelle(s) est/sont celle(s) ne constituant pas un critère pour le choix d'un indicateur :

A- En relation avec l'attente du client

B- Repose sur un fait

C- Sensibilité aux actions
d'amélioration des prestations

D- Permet l'expression des besoins

Rep:

27- Parmi les propositions suivantes quelle(s) est/sont l'indicateur (les) arrêtés(s) pour le suivi de la MEO du programme d'action visant l'amélioration auprès des usagers des services rendus par les hôpitaux publics :

www.ispits.net

A- Taux de mortalité néo-natale pour 1000 naissances

B- Admissions en hospitalisation de jour

C- Pourcentage de la pop couverte par le RAMED

D- Taux d'occupation moyenne

Rep:

28- L'évaluation des soins comme outil de gestion :

A- Aide à l'utilisation optimale des ressources

B- Est utile pour évaluer l'opportunité et l'efficacité des programmes de santé

C- Prévoit les ressources nécessaires à la dispensation des soins

D- Facilite au mieux la satisfaction des besoins des pop concernées

Rep:

29- L'appréciation de la satisfaction des usagers renseigne sur :

A- La qualité des prestations fournies

B- l'organisation des services de santé

C- Le cout des prestations fournies

D- Les activités des établissements de
santé

Rep:

30- Quelle est la définition exacte de la mortalité infantile :

A- Le nombre d'enfants décédés dans les 24 H qui suivent la naissance

B- Le nombre d'enfants décédés avant d'atteindre 1 an

C- Le nombre d'enfant décédés avant 5 ans

D- Le nombre de morts nés

Rep:

31- Quelle expression correspond à la définition suivante? « différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité dans la même année » :

A- Taux de mortalité

B- Accroissement naturel

C- Taux d'accroissement

D- Taux de natalité

Rep:

32- Que signifie le sigle SAMU :

www.ispits.net

- A- Secours ambulatoires municipaux d'urgence
- B- Service ambulatoire médical d'urgence
- C- Service d'aide médicale d'urgence
- D- Service d'assistance médicale d'urgence

Rep: